

Врач говорит — история болезни пишется сама

Предложение для клиники. Голосовая медицинская документация для стационара: на русском — сегодня, на таджикском — собственная модель распознавания, обучена и готовится к запуску. Работает рядом с вашей нынешней системой, не заменяя её.

Для: Дата:

Поступление → Первичный осмотр → Ежедневные дневники → Обход → Анализы → Выписной эпикриз

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА ОБХОДЕ

ВРАЧ ГОВОРИТ ВСЛУХ

«Каримова, третья палата, вторые сутки после холецистэктомии. Жалуется на боль в области шва. Температура 37,2, давление 130 на 80, пульс 78. Швы чистые, признаков воспаления нет. Продолжаем цефтриаксон, перевязка завтра.»

СИСТЕМА ПИШЕТ ЗА НЕГО

Готовый дневник в формате 003/y: жалобы, объективный статус, оценка, план — с ФИО, датой и номером карты. Температура, давление и пульс отдельно попадают в лист наблюдения и на экран реанимации. **Врач читает, при необходимости правит и подписывает.**

ЧТО ЭТО ДАЁТ ОТДЕЛЕНИЮ

Стационарный контур целиком

Поступление, первичный осмотр, ежедневные дневники, эпикриз в один тап. Формат 003/y, а не переведённый западный шаблон.

Ночной обход голосом

Врач идёт по палатам и говорит подряд. Система сама определяет, к какому пациенту относится каждая фраза, и раскладывает витальные по картам.

Экран реанимации

Состояние тяжёлых пациентов на одном экране, с цветовыми порогами и вызовом врача. Для ОРИТ и послеоперационных отделений.

Связь с лабораторией

Направление превращается в QR-код. Результат возвращается в карту к лечащему врачу, а не пациенту на руки. С пояснением к показателям.

КОМУ ЭТО ПОДХОДИТ

- Клиникам со стационаром: там, где ведут дневники и пишут эпикризы, пользы больше всего
- Отделениям реанимации и послеоперационным — экран тяжёлых пациентов и голосовой обход
- Клиникам с собственной лабораторией — петля «направление → результат» замыкается без посредников
- Там, где врачи ведут записи на таджикском: ни один международный сервис его не поддерживает — мы обучили собственную модель

ДАННЫЕ ПАЦИЕНТОВ

- Записи хранятся в базе клиники, доступ — только у лечащего врача
- Каждое действие с картой фиксируется в журнале аудита
- Отчёты об ошибках уходят разработчику без единого медицинского поля — проверено на перехвате трафика
- Аудиозапись не сохраняется нигде: файл распознаётся и удаляется
- На время пилота распознавание идёт через внешний сервис. После запуска собственной модели речь не покидает наш контур

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БЕСПЛАТНЫЙ ПИЛОТ НА ОДИН МЕСЯЦ, 10 ВРАЧЕЙ

- **Один месяц, десять врачей** — состав и отделения выбираете вы
- Полная стоимость для клиники: **0 сомони**. Ни оплаты, ни обязательств продолжать
- Запуск за один день: ноутбук или телефон, устанавливать ничего не нужно
- Обучение врачей и сопровождение всё время пилота — с нашей стороны
- Ваша нынешняя система документации остаётся, мы её не трогаем
- По итогам — письменный отчёт: сколько записей, сколько правок, что говорят врачи

Что дальше. Если по итогам месяца врачи захотят продолжить — подписка от 39 долларов за врача в месяц: это до 100 приёмов, при большем потоке тариф выше. В 2,5–5 раз дешевле западных аналогов. Если не захотят — мы расходимся, и вы ничего не должны.

О нас честно. Avris создан в Душанбе и работает в продакшене, но клинического пилота ещё не проходил — ваша клиника может стать первой. Продукт построил практикующий клинический ординатор, который сам ведёт документацию каждый день. Шесть технических решений поданы на патент через НЦИС Таджикистана. Мы не обещаем цифр экономии времени, которых пока не измеряли, — именно это и хотим измерить вместе с вами.

Шахзод Нарзуллоев — основатель, клинический ординатор **Душанбе**

theavris.ai · демонстрация занимает 15 минут

Hyperion Labs
2026

Табиб мегӯяд — таърихи беморӣ худ навишта мешавад

Пешниҳод барои клиника. Ҳуҷҷатгузорию овозии тиббӣ барои беморхона: бо забони русӣ — имрӯз, бо забони тоҷикӣ — модели ҳудамон омӯзонида шудааст ва ба зудӣ ба қор мебарояд. Дар паҳлӯи системаи ҳозираи шумо қор мекунад, онро иваз намекунад.

Барои: _____ Сана: _____

Қабул → Муоинаи аввалия → Рӯзномаи ҳаррӯза → Гашти шабона → Таҳлилҳо → Эпикризи хуруҷ

ДАР ГАШТ ЧӢ ГУНА БА НАЗАР МЕРАСАД

ТАБИБ БО ОВОЗ МЕГӢЯД

«Каримова, палатаи сеюм, рӯзи дуюм пас аз ҳолатсистэктомия. Аз дарди ҷои дӯхт шикоят мекунад. Ҳарорат 37,2, фишор 130 ба 80, набз 78. Ҷои дӯхт тоза, аломати илтиҳоб нест. Сефтриаксонро давом медиҳем, бандубаст пагоҳ.»

СИСТЕМА БА ҶОИ Ӣ МЕНАВИСАД

Рӯзномаи тайёр дар шакли 003/у: шикоятҳо, ҳолати объективӣ, баҳо, нақша — бо ному насаб, сана ва рақами қорт. Ҳарорат, фишор ва набз алоҳида ба варақаи мушоҳида ва ба экрани реанимация мераванд.

Табиб меҳонад, зарур бошад ислоҳ мекунад ва имзо мегузорад.

ИН БА ШӢЪБА ЧӢ МЕДИҲАД

Тамоми давраи бистарӣ

Қабул, муоинаи аввалия, рӯзномаҳои ҳаррӯза, эпикриз бо як тугма. Дар шакли 003/у, на тарҷумаи қолаби ғарбӣ.

Гашти шабона бо овоз

Табиб аз палата ба палата мегузарад ва пай дар пай мегӯяд. Система ҳудаш муайян мекунад, ки ҳар ҷумла ба қадом бемор тааллуқ дорад.

Экрани реанимация

Ҳолати беморони вазнин дар як экран, бо ранги ҳушдор ва тугмаи даъвати табиб. Барои ОРИТ ва шӯъбаҳои пас аз қарроҳӣ.

Пайванд бо лаборатория

Равонкунӣ ба QR-код табдил меёбад. Натиҷа ба қорти бемор, ба назди табиби муолиҷакунада бармегардад — на ба дасти бемор.

БА КӢ МУВОФИҚ АСТ

- Ба клиникаҳои дорои шӯъбаи бистарӣ: он ҷо ки рӯзнома мебаранд ва эпикриз менависанд, ғоидааш бештар аст
- Ба шӯъбаҳои реанимация ва пас аз қарроҳӣ — экрани беморони вазнин ва гашти овозӣ
- Ба клиникаҳои дорои лабораторияи ҳудӣ — давраи «равонкунӣ → натиҷа» бе миёнарав пӯшида мешавад
- Он ҷо ки табибон сабтҳоро бо тоҷикӣ мебаранд: ягон хидмати байналмилалӣ тоҷикиро намефаҳмад — мо модели ҳудамонро омӯзондем

МАӢЛУМОТИ БЕМОРОН

- Сабтҳо дар базаи клиника нигоҳ дошта мешаванд, дастрасӣ — танҳо барои табиби муолиҷакунада
- Ҳар амал бо қорти бемор дар журнали аудит сабт мешавад
- Гузоришҳо дар бораи хатоҳо ба таҳиягар бе ягон майдони тиббӣ мераванд
- Сабти овозӣ дар ҳеҷ ҷо нигоҳ дошта намешавад: файл шинохта шуда, нест қарда мешавад
- Дар давоми озмоиш шинохти нутқ тавассути хидмати берунӣ мегузарад. Пас аз модели ҳудамон нутқ аз контури мо берун намебарояд

ПЕШНИҲОД: ОЗМОИШИ РОЙГОН БА МУДДАТИ ЯК МОӢ, 10 ТАБИБ

- Як моҳ, даҳ табиб** — ҳайат ва шӯъбаҳоро шумо интиҳоб мекунад
- Арзиши пурра барои клиника: **0 сомонӣ**. На пардохт, на ӯҳдадорӣ давом додан
- Оғоз дар як рӯз: ноутбук ё телефон, чизе насб қардан лозим нест
- Омӯзиши табибон ва дастгирӣ дар тамоми давраи озмоиш — аз ҷониби мо
- Системаи ҳозираи ҳуҷҷатгузорию шумо боқӣ мемонад
- Дар охир — гузориши хаттӣ: чанд сабт, чанд ислоҳ, табибон чӣ мегӯянд

Баъд аз он чӣ мешавад. Агар пас аз як моҳ табибон давом доданӣ шаванд — обуна аз 39 доллар барои як табиб дар як моҳ: ин то 100 қабул аст, ҳангоми қараёни зиёдтар тарифи болотар. 2,5–5 маротиба арзонтар аз аналогҳои ғарбӣ. Агар нахоҳанд — мо ҷудо мешавем ва шумо ба мо чизе қарздор нестед.

Дар бораи мо ростқавлона. Avris дар Душанбе сохта шудааст ва дар қор аст, вале то ҳол дар ягон клиника озмоиш нагузаштааст — клиникаи шумо метавонад аввалин бошад. Системаро табиби ординатори клиникӣ сохтааст, ки ҳудаш ҳар рӯз ҳуҷҷат мебарад. Шаш ҳалли техникӣ тавассути НЦИС-и Тоҷикистон ба патент пешниҳод шудаанд. Мо рақамҳои сарфаи вақтро ваъда намедихем, зеро онҳоро ҳанӯз чен накардаем.